Pensamiento de Ingeniería · Definición del problema

Prometieron Dinamarca, entregaron desabasto: cómo Morena le falló al IMSS

Definición del problema: la capacidad del IMSS es insuficiente frente a la demanda de sus derechohabientes

Equipo: Jorge Velázquez de León, Gabriel Attie y Nathan Marcos

Fecha: octubre de 2026

1. Necesidad detectada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a la mayoría de los trabajadores formales del país y a sus familias. Hoy le faltan camas, médicos, enfermeras, equipo y medicamentos: hay recetas que no se surten, pacientes que esperan meses por una cirugía y personal médico que salió a las calles a protestar. Los derechohabientes pagan cuotas para tener atención, pero cuando el servicio falla terminan pagando de su bolsillo en farmacias y consultorios privados.

En diciembre de 2022, el presidente López Obrador prometió que a más tardar a finales de 2023 México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca; después movió la meta a marzo de 2024 [9]. Hoy el país tiene una cama de hospital por cada mil habitantes, contra 4.2 en la OCDE [3]. Este trabajo sostiene que el problema del IMSS no es solo un rezago heredado: los gobiernos de Morena, con el poder para cambiarlo, tomaron decisiones que lo empeoraron.

2. Investigación: evidencia del problema

Inversión pública en salud

2.6 %
del PIB va a salud pública en el presupuesto 2026 [1]

6 %
del PIB es el mínimo que recomienda la OMS [1]

−4.7 %
recursos de salud 2026 frente a lo ejercido en 2024 [2]

63.3 %
de la población tenía carencia de acceso a salud en 2024 [2]

El gasto programable en salud promedió 2.2 % del PIB con Felipe Calderón, 2.5 % con Enrique Peña Nieto y 2.6 % con Andrés Manuel López Obrador [1]. Para 2026 sube 5.9 % real frente a 2025, pero sigue por debajo de la mitad de lo recomendado [1].

Capacidad instalada comparada con la OCDE [3]

Indicador	México	Promedio OCDE
Camas de hospital por cada 1,000 habitantes	1.0	4.2
Médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes	2.7	3.9
Enfermeras por cada 1,000 habitantes	3.0	9.2
Tomógrafos, resonancias y PET por millón de habitantes	10	51
Gasto en salud por persona (dólares PPA, 2024)	1,588	5,967

Situación dentro del IMSS

- **Medicamentos:** según el Programa Institucional 2025-2030 del propio IMSS, en 2024 se emitieron 214.5 millones de recetas y unos 4.68 millones (2.2 %) no se surtieron o no se entregaron al momento [4]. A finales de 2025, los proveedores habían entregado solo cerca de 73 % de los medicamentos e insumos a nivel nacional [5].
- **Personal:** los propios trabajadores denuncian plazas vacantes sin cubrir, sobrecarga de trabajo y equipo médico que no funciona [12].

3. La voz de quienes lo viven: la protesta del 12 de octubre de 2026

El 12 de octubre de 2026, trabajadores del IMSS intensificaron una ola de protestas que llevaba varios días. En la Ciudad de México bloquearon al menos seis vialidades, entre ellas Eje Central y Doctor Vértiz, protestaron afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI y mantuvieron un campamento en Paseo de la Reforma. También hubo movilizaciones en Toluca, Metepec, Monterrey y Hermosillo, y plantones en Puebla, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua y Coahuila. Convocaron además a una marcha nacional al día siguiente, del Centro Médico Siglo XXI a Palacio Nacional [11].

Qué exigen

- Un aumento directo de 10 % al salario; rechazan la oferta oficial de 6.8 %, de la cual solo 2.9 % va al salario base [11][12].
- Medicamentos, material de curación e insumos suficientes para atender a los pacientes [12].
- Cubrir las plazas vacantes y reducir las cargas de trabajo [12].
- Equipo médico que funcione y mantenimiento de las instalaciones [12].
- Un retiro digno y la salida de su dirigente sindical, al que acusan de no representarlos [12][13].

Lo que dicen los manifestantes

En sus lonas, el personal escribió que está *"defendiendo lo justo para atenderte mejor"* [13]: su protesta no es solo por sueldos, sino porque sin medicinas ni equipo no pueden atender bien a nadie.

Una doctora de una clínica en Guanajuato advirtió que, aunque se manifestaban sin afectar el servicio, podían llegar a irse a paro [13]. Las mesas de diálogo en la Ciudad de México terminaron sin acuerdos [13].

Qué respondió el gobierno

Zoé Robledo anunció una estrategia de "escucha activa" en 277 hospitales para recoger las peticiones del personal [11]. La presidenta Sheinbaum reconoció problemas de abasto y llamó "legítimas" las demandas, pero rechazó que el IMSS viva una crisis generalizada [12]. Es decir: el gobierno reconoce las quejas, pero no el tamaño del problema.

4. Usuarios y partes interesadas

Afectados directos

- Derechohabientes del IMSS (trabajadores formales y sus familias).
- Pacientes con enfermedades crónicas que dependen de medicamentos continuos.
- Personal médico, de enfermería y administrativo del IMSS.

Quienes deciden o influyen

- Presidencia y Secretaría de Hacienda (proponen el presupuesto).
- Cámara de Diputados (aprueba el presupuesto).
- Dirección general del IMSS y Secretaría de Salud.
- Sindicato de trabajadores (SNTSS) y proveedores de medicamentos.

5. Análisis de causas y consecuencias

Causas

- Gasto público en salud históricamente bajo, menos de 3 % del PIB [1].
- Cambios fallidos en la compra de medicamentos desde 2019 [6].
- Proveedores que no entregan y fallas para llevar medicinas del almacén a la farmacia [5] [12].
- Desaparición del Seguro Popular, que aumentó la presión sobre el sistema público [8].
- Plazas vacantes y salarios bajos del personal [11][12].

Consecuencias

- Recetas no surtidas y tratamientos interrumpidos [4].
- Largas esperas para cirugías y especialistas.
- Más gasto de bolsillo en farmacias y consultorios privados.
- Personal agotado que protesta y amenaza con paro [11][13].
- Mortalidad tratable de 175 por cada 100,000 habitantes, contra 77 en la OCDE [3].
- Pérdida de confianza en la institución.

5.1 Los responsables: cómo Morena agravó la crisis (2018-2026)

Morena gobierna el país desde diciembre de 2018 y, junto con sus aliados, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba cada peso del presupuesto. Durante casi ocho años tuvo el poder y los votos para cambiar la situación del IMSS. Estos son los resultados.

Promesa contra realidad

Lo que prometieron	Lo que pasó
Un sistema de salud "como el de Dinamarca" para finales de 2023 [9]	México tiene 1 cama por cada mil habitantes (la OCDE, 4.2) y gasta 1,588 dólares por persona contra 5,967 de la OCDE [3]
Medicinas gratis y suficientes para todos	Las recetas no surtidas efectivamente en el IMSS pasaron de 1.47 millones en 2018 a 12.5 millones en 2022: **8 veces más** [7]
Sustituir el Seguro Popular por un sistema mejor (INSABI)	Unos 15 millones de personas perdieron acceso a servicios de salud y el INSABI desapareció en 2023, tres años después de crearse [8]
Acabar con la corrupción en las compras	Las compras sin licitación subieron de 40.7 % en 2018 a 65.5 % en 2021, y las piezas compradas cayeron de unos 1,747 a unos 1,000 millones [6]

Cinco decisiones que costaron caro

1. **Desmantelaron la compra de medicamentos sin tener un reemplazo.** En 2019 le quitaron la compra consolidada al IMSS y la pasaron a Hacienda, luego al INSABI y luego a la UNOPS: cambiaron de modelo hasta cuatro veces y ninguno funcionó [6]. El resultado fue el peor desabasto en la historia reciente del IMSS [7].
2. **Eliminaron el Seguro Popular sin diagnóstico ni dinero extra.** El INSABI quiso atender a más personas con el mismo presupuesto, y las consultas de cáncer para mujeres cayeron 59 % entre 2016 y 2022 [8].
3. **Manejaron mal la pandemia con un sistema ya debilitado.** La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia contó unas 800,000 muertes en exceso y considera que unas 300,000 pudieron evitarse; también registró unos 5,000 trabajadores de la salud fallecidos [10].
4. **Pusieron el dinero en otras prioridades.** En 2026, salud recibe 4.7 % menos de lo ejercido en 2024 [2], y el gasto sigue en 2.6 % del PIB, menos de la mitad de lo recomendado [1].
5. **Minimizaron el problema.** Ante la falta de medicinas para cáncer, el director del IMSS declaró que *"la solución es no enfermarnos"* [5]. En 2026, la presidenta rechazó que haya una crisis generalizada [12], mientras el personal protestaba en las calles.

Lo que responde Morena, y por qué no alcanza

"Los gobiernos anteriores invirtieron todavía menos." Es cierto: 2.2 % del PIB con Calderón y 2.5 % con Peña Nieto [1]. Pero con Morena apenas subió a 2.6 %, muy lejos del 6 % recomendado, y el desabasto se disparó a niveles que esos gobiernos nunca tuvieron [7]. Heredar un problema no justifica empeorarlo.

"Estamos construyendo hospitales y comprando equipo." El IMSS sí ha anunciado hospitales nuevos y compra de equipo. Pero con 1 cama por cada mil habitantes, unos cuantos hospitales no cierran una brecha de más de tres camas por cada mil frente a la OCDE [3], y llegaron después de años de desabasto.

5.2 Con nombre y apellido: quién tomó las decisiones

Estas decisiones tienen responsables con cargo y declaraciones públicas.

Persona	Cargo	Lo que hizo o dijo
Andrés Manuel López Obrador	Presidente, 2018-2024	Eliminó el Seguro Popular y creó el INSABI, que dejó a unos 15 millones sin acceso a servicios y desapareció en 2023 [8]. Prometió un sistema de salud como el de Dinamarca para 2023 y luego aplazó la fecha [9].
Claudia Sheinbaum	Presidenta, desde 2024	Su presupuesto 2026 deja a salud con 4.7 % menos de lo ejercido en 2024 [2]. Ante las protestas, negó que el IMSS viva una crisis generalizada [12].
Hugo López-Gatell	Subsecretario de Salud; encabezó la respuesta al COVID-19	La Comisión Independiente le atribuye minimizar el uso de cubrebocas y manejar mal los datos. En 2025 fue nombrado representante de México ante la OMS, y la Comisión lo calificó como una falta de respeto a las víctimas [10].

Zoé Robledo	Director general del IMSS, desde 2019	Dijo que "la solución es no enfermarnos" ante la falta de medicinas para cáncer [5]. Su propio instituto reconoce 4.68 millones de recetas no surtidas o no entregadas al momento en 2024 [4].

Nota: la tabla señala decisiones y declaraciones públicas documentadas; no acusa a nadie de delitos.

6. Enunciado del problema

> Los derechohabientes del IMSS necesitan recibir atención médica oportuna (consultas, cirugías y medicamentos) porque cotizan para ello y es su derecho, pero actualmente la capacidad del Instituto (camas, personal, equipo e insumos) es insuficiente frente a la demanda. El rezago viene de décadas de inversión por debajo del 3 % del PIB, pero los gobiernos de Morena lo agravaron desde 2018: desmantelaron la compra de medicamentos, eliminaron el Seguro Popular sin un reemplazo funcional y mantuvieron un presupuesto de salud muy lejos de lo necesario, pese a tener la mayoría para cambiarlo.

7. Requerimientos de una posible solución

- Aumentar la capacidad de atención del IMSS (camas, consultorios, quirófanos o personal) de forma medible.
- Reducir los tiempos de espera para cirugías y consultas de especialidad.
- Mejorar el porcentaje de recetas surtidas completas al momento.
- Ser financieramente sostenible a largo plazo, no solo una inversión de un año.
- Poder evaluarse con datos públicos y verificables.

8. Restricciones

- **Presupuesto:** los recursos públicos son limitados y compiten con otras prioridades.
- **Marco legal:** debe respetar la Ley del Seguro Social y las reglas de compras públicas.
- **Tiempo:** construir un hospital o formar a un especialista toma años.
- **Recursos humanos:** no basta con construir; cada cama nueva necesita personal para operarla.
- **Geografía:** la demanda y el rezago no son iguales en todos los estados.

9. Criterios de éxito (cómo medir)

Indicador	Situación actual	Dirección deseada
Camas de hospital por cada 1,000 habitantes	1.0 [3]	Acercarse al promedio de la OCDE (4.2)
Recetas no surtidas al momento	4.68 millones en 2024 [4]	Acercarse a cero
Gasto público en salud	2.6 % del PIB [1]	Aumento sostenido hacia 6 %
Entrega de proveedores	Cerca de 73 % [5]	100 % a tiempo

10. Propuesta de solución básica (punto de partida)

Como esta etapa es de definición, la propuesta es solo un borrador para desarrollar después. Ataca la parte del problema que se puede resolver más rápido y con menos dinero: que el medicamento que sí se compró llegue al paciente.

Idea: "Receta Segura", un sistema de abasto con trazabilidad y predicción

1. **Trazabilidad de cada medicamento.** Registrar cada lote desde que el proveedor lo entrega hasta que sale de la farmacia de la clínica, con código de barras o QR. Así se sabe en qué punto se atora: proveedor, almacén o transporte, que es una de las fallas que hoy se señalan [5][12].
2. **Predicción de la demanda.** Usar el historial de recetas de cada clínica para estimar cuánto de cada medicamento se va a necesitar el mes siguiente, y comprar y distribuir con anticipación en lugar de reaccionar al faltante.

3. **Alertas y redistribución.** Cuando una clínica esté por quedarse sin un medicamento, el sistema avisa y sugiere trasladarlo desde otra unidad cercana que tenga de más.
4. **Tablero público.** Publicar el porcentaje de abasto por clínica y el cumplimiento de cada proveedor, para que el desabasto no se pueda negar y los proveedores que incumplen queden expuestos.

Cómo responde a los requerimientos

- Mejora directamente el porcentaje de recetas surtidas, medible con los datos que el propio IMSS ya genera.
- Cuesta mucho menos que construir hospitales y puede probarse primero en una sola delegación.
- La transparencia del tablero hace que el resultado se pueda verificar públicamente.

Lo que falta definir (para que ustedes lo moldeen)

- ¿Con qué región o clínicas se haría la prueba piloto?
- ¿Qué datos de recetas existen y cómo se obtendrían?
- ¿Qué técnica de predicción usar, desde un promedio móvil sencillo hasta un modelo de aprendizaje automático?
- ¿Cuánto costaría y quién lo operaría?
- ¿Se combina con una propuesta de más presupuesto para camas y plazas, que es la otra mitad del problema?

11. Alcance

Sí incluye: la relación entre el nivel de inversión y las decisiones de gobierno con la capacidad de atención del IMSS (régimen ordinario): infraestructura, personal, equipo y abasto de medicamentos.

No incluye: el ISSSTE, el IMSS-Bienestar ni el sector privado; tampoco las pensiones del IMSS. La solución de la sección 10 es un punto de partida, no un diseño final.

Fuentes

1. Expansión (2025). El gasto en salud subirá en 2026, pero seguirá siendo insuficiente. expansion.mx
2. Uno TV (2025). Gasto en salud 2026 sigue siendo insuficiente (análisis del CIEP). unotv.com
3. N+ (2025). OCDE: Panorama de la Salud, datos de México. nmas.com.mx
4. La Crónica (2026). 4.68 millones de recetas no surtidas o no entregadas en el IMSS. cronica.com.mx

5. Animal Político (2025). Proveedores solo han entregado 70 % de insumos médicos al IMSS. grupoanimal.mx
6. La Razón (2022). Desorganización tira compra de medicinas. razon.com.mx
7. Vanguardia. Datos de Cero Desabasto sobre recetas no surtidas, 2018-2022. vanguardia.com.mx
8. Expansión Política (2023). En busca del tiempo que perdió el INSABI. expansion.mx
9. Expansión Política (2023). AMLO aplaza a marzo de 2024 el sistema de salud como el de Dinamarca. expansion.mx
10. ADN40 (2025). Comisión COVID rechaza a López-Gatell como representante ante la OMS. adn40.mx
11. Expansión Política (2026). Trabajadores del IMSS intensifican protestas y bloquean vialidades. expansion.mx
12. Infobae (2026). Por qué no hay medicinas en el IMSS y qué dice el gobierno de Sheinbaum. infobae.com
13. LatinUS (2026). Personal del IMSS en Guanajuato mantiene protestas por bajos salarios y desabasto. latinus.us